Examen Tipo Test - OpoGen

Número de preguntas: 50

1. En el marco teórico de la comunicación clínica, ¿cuándo se considera que el acto comunicativo resulta formalmente eficaz?

A) Cuando el emisor expone la totalidad del mensaje clínico sin interrupciones.

B) Cuando el canal utilizado carece de interferencias o barreras ambientales.

C) Cuando el receptor interpreta el mensaje en los términos pretendidos por el emisor.

D) Cuando el receptor manifiesta verbalmente su adhesión terapéutica plena.

2. Conforme al protocolo de acogida en UCI, ¿en qué supuesto se justifica la aplicación de barreras de protección individual a los familiares visitantes?

A) De forma generalizada durante toda la estancia, para minimizar el riesgo de infecciones cruzadas.

B) Únicamente cuando el paciente presente infección por microorganismos con mecanismos de resistencia, como KPC, para asegurar el aislamiento de contacto.

C) Siempre que el familiar solicite acompañar al paciente durante un procedimiento invasivo.

D) Cuando el paciente se encuentre incapacitado y la familia deba participar en la toma de decisiones.

3. ¿En qué momento deben aprender los sanitarios a comunicarse con cariño?

A) Solo al jubilarse

B) Nunca en su vida

C) Durante toda su formación

D) Solo los fines de semana

4. Respecto a la identificación de 'A QUIÉN comunicar', ¿qué praxis errónea advierte el documento en el abordaje asistencial?

A) Excluir a los tutores legales en casos de incapacidad formal manifiesta.

B) Comunicar el diagnóstico directamente al menor emancipado sin consentimiento.

C) Dirigir por defecto la información a los familiares asumiendo la incapacidad del usuario.

D) Informar al paciente sin la presencia obligatoria de un testigo administrativo.

5. En materia de participación de los familiares en los cuidados del paciente crítico, ¿cuál de las siguientes actuaciones se contempla expresamente en el protocolo?

A) Imponer la implicación de la familia en los cuidados, con independencia de su voluntad.

B) Valorar la estructura familiar para identificar potenciales cuidadores, siempre que estos lo deseen.

C) Limitar la formación de los familiares a los aspectos meramente informativos del ingreso.

D) Reservar la participación familiar exclusivamente a los ingresos no programados.

6. Cuando el paciente crítico se encuentra incapacitado, la toma de decisiones sobre el tratamiento o cualquier procedimiento debe:

A) Adoptarse de forma unilateral por el equipo sanitario, dada la urgencia vital.

B) Delegarse íntegramente en el familiar de mayor grado de parentesco.

C) Compartirse con la familia, apoyándose en herramientas validadas para la ayuda en la toma de decisiones.

D) Suspenderse hasta que el paciente recupere su capacidad de obrar.

7. En relación con la atención psicosocial al paciente, el material destaca como actuación del profesional:

A) Escuchar y permitir que el paciente exprese sus emociones y miedos

B) Restringir la información a la familia para evitar alarma

C) Limitar la comunicación a los aspectos estrictamente clínicos

D) Priorizar la cumplimentación documental sobre la escucha activa

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se desprende del contenido de la guía en cuanto a la atención psicosocial al paciente?

A) El profesional debe identificar las necesidades de información del paciente y responder a ellas.

B) El profesional debe priorizar la información clínica sobre la emocional.

C) El profesional debe evitar hablar de temas que puedan angustiar al paciente.

D) El profesional debe remitir al paciente a recursos externos para apoyo emocional.

9. Conforme a la guía citada, ¿qué dos unidades hospitalarias requieren una especial actuación por la deshumanización que conlleva la pandemia?

A) UCI y Servicio de Urgencias.

B) Hospitalización y Consultas Externas.

C) UCI y Hospitalización.

D) Servicio de Urgencias y Quirófano.

10. Según el texto, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que el modelo restrictivo de visitas en UCI se mantuvo implantado durante tanto tiempo?

A) La evidencia científica demostraba que perjudicaba la seguridad del paciente.

B) La costumbre y la falta de crítica sobre los inconvenientes de dicho modelo.

C) La limitada estructura del box y la vulneración de la intimidad de otros pacientes.

D) La mayor dificultad para realizar los cuidados enfermeros que generaba en los profesionales.

11. Según la guía de acompañamiento para pacientes ingresados por COVID-19, ¿qué finalidad principal se persigue con la comunicación entre el profesional y el paciente?

A) Mantener una buena comunicación que contribuya a disminuir la incertidumbre del paciente.

B) Cumplir con el protocolo de información clínica establecido por el centro.

C) Registrar en la historia clínica las emociones manifestadas por el paciente.

D) Delegar en el acompañante la responsabilidad de informar al paciente.

12. En relación con la atención psicosocial al paciente prevista en la guía, ¿por qué se indica expresamente que el profesional debe identificarse?

A) Porque el paciente tiene derecho a conocer la categoría profesional de quien le atiende.

B) Porque los equipos de protección individual dificultan que el paciente lo reconozca.

C) Porque así se evita que el paciente confunda al personal sanitario con el no sanitario.

D) Porque lo exige el protocolo de trazabilidad de contactos.

13. ¿Qué experiencia previa se invoca en el texto como fundamento para plantear la adaptación del modelo de puertas abiertas a las UCI de adultos?

A) La de las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas y neonatales, donde la familia se considera pilar fundamental del cuidado íntegro.

B) La de las unidades de hospitalización convencional, donde la visita se flexibilizó sin incidencias reseñables.

C) La de los servicios de urgencias, que ya aplicaban horarios de visita ampliados con resultados positivos.

D) La de las unidades de cuidados paliativos, donde la familia participa en los cuidados desde hace décadas.

14. Conforme al material, la obligación de responder a las necesidades de información o dudas del paciente se enmarca dentro de:

A) La buena comunicación que el profesional debe mantener con el paciente

B) Las funciones del acompañante familiar

C) Los criterios de ingreso en unidades de críticos

D) El protocolo de visitas del centro

15. De acuerdo con la bibliografía recogida en el material, ¿qué documento se identifica como guía de acompañamiento para pacientes ingresados del COVID-19?

A) El publicado por ForoHURGE en 2020

B) El elaborado por el Comité de Ética del Área I del Servicio Murciano de Salud

C) El aprobado por el Ministerio de Sanidad en 2021

D) El emitido por la Organización Mundial de la Salud en 2019

16. Según el material, ¿qué teoría propia ha construido la bioética como conjunto de principios éticos destinados a orientar la resolución de conflictos en la práctica biomédica?

A) La teoría hipocrática clásica.

B) El principalismo.

C) La ética práctica aristotélica.

D) El paternalismo clínico.

17. Entre las obligaciones que la guía impone al acompañante del paciente, se encuentra informarle de determinados extremos. ¿Cuál de los siguientes NO se recoge expresamente en el texto?

A) Los riesgos de adquirir la enfermedad.

B) Los riesgos específicos derivados de su propia situación de salud.

C) La obligación de realizar cuarentena posteriormente.

D) La obligación de firmar un consentimiento informado ante notario.

18. Según el texto, ¿qué efecto concreto se llega a asegurar por algunos autores en relación con la cercanía de un ser querido al paciente en UCI?

A) La reducción de la estancia media en la unidad de cuidados intensivos.

B) La mejora de la actividad cardíaca de los pacientes.

C) La disminución de la necesidad de sedación farmacológica.

D) La reducción de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

19. En relación con el origen de la bioética como disciplina, ¿qué comisión e informe se citan en el material y cuál fue su tarea inicial?

A) Una comisión creada en 1974 en EEUU que asumió la tarea de identificar los principios éticos básicos que guiarían la investigación con seres humanos, dando lugar al informe Belmont.

B) Una comisión europea de 1974 que elaboró el informe Belmont para regular la práctica asistencial en hospitales.

C) Una comisión estadounidense posterior a 1974 que añadió el principio de no maleficencia al informe Belmont.

D) Una comisión creada en 1974 en EEUU que redactó el informe Belmont para establecer los principios de la deontología profesional.

20. ¿Qué hace un monitor central en el hospital?

A) Ver la información de todos los enfermos desde fuera

B) Preparar la comida

C) Limpiar las habitaciones

D) Apagar las luces

21. Según el texto, ¿qué rol activo deben asumir los profesionales para integrarse en la humanización del sistema?

A) La sustitución de la gestión de recursos tradicionales por asambleas ciudadanas.

B) La implicación directa en la elaboración de protocolos y en la comunicación interna.

C) La supervisión exclusiva de los circuitos administrativos en áreas pediátricas.

D) El relevo de las familias en la aplicación de técnicas asistenciales complejas.

22. ¿Qué se puede poner en el hospital para que el enfermo se distraiga?

A) Un jardín o un patio

B) Más ruido

C) Menos luz

D) Puertas cerradas

23. En el marco de la humanización de Urgencias, ¿qué medida específica se prescribe para pacientes vulnerables?

A) La limitación de visitas a franjas horarias estrictas para preservar la intimidad.

B) El traslado automático a neonatología para implementar el método canguro.

C) La habilitación de un circuito diferenciado que garantice el acompañamiento continuo.

D) La exclusión del acompañamiento durante la realización de técnicas diagnósticas.

24. Conforme al material, ¿qué principio bioético se configura como regla del consentimiento libre e informado, impidiendo que se impongan decisiones al paciente por ignorancia o por fuerza?

A) El principio de beneficencia, en tanto que obliga al profesional a procurar el bien del paciente.

B) El principio de autonomía, que comprende el derecho a equivocarse en la elección.

C) El principio de no maleficencia, identificado con el aforismo primum non nocere.

D) El principio de justicia, orientado a la resolución de conflictos en contextos plurales.

25. ¿Quién recibe y escucha la información en una conversación?

A) El receptor

B) El emisor

C) El papel

D) El mensaje

26. Según la guía elaborada por el Comité de Ética del Área I del Servicio Murciano de Salud, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acompañamiento del paciente es correcta?

A) El acompañamiento está justificado en todo paciente ingresado, sin necesidad de valorar el criterio clínico del momento.

B) El acompañamiento está de sobra justificado en algunos pacientes, aunque debe tenerse en cuenta el criterio clínico del paciente en ese momento.

C) El acompañamiento solo se autoriza cuando existe fallecimiento inmediato, excluyendo cualquier otra circunstancia.

D) El acompañante no requiere información sobre los riesgos, pues la decisión corresponde exclusivamente al profesional sanitario.

27. ¿En qué guía de buenas prácticas se basan la mayoría de protocolos o Guías de Práctica Clínica para desarrollar sus objetivos y estrategias, según el texto?

A) En la guía de buenas prácticas del Plan HU-CI.

B) En las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

C) En los protocolos de las Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas y neonatales.

D) En las guías de práctica clínica de las unidades de hospitalización convencional.

28. ¿Qué ocurre cuando un enfermo entiende bien los consejos del médico?

A) Se cuida y recupera mejor

B) Se confunde más

C) Toma peores decisiones

D) Se enfada con todos

29. ¿Cuál de los siguientes objetivos NO se atribuye expresamente a la Guía de acompañamiento elaborada por el Comité de Ética del Área I del Servicio Murciano de Salud?

A) Crear estrategias y mecanismos seguros para las diferentes áreas de hospitalización.

B) Facilitar documentos a los profesionales sanitarios para valorar la idoneidad del acompañamiento.

C) Establecer un régimen sancionador para los familiares que incumplan la cuarentena.

D) Proporcionar información a los familiares por circuitos adecuados.

30. ¿Quién ayuda a un niño enfermo a estar tranquilo en el hospital?

A) Un desconocido

B) Su familia

C) Un juguete roto

D) Nadie

31. ¿Cómo se llama el cuidado donde los padres abrazan al bebé en el pecho?

A) Método canguro

B) Salto de rana

C) Carrera de osos

D) Nido de pájaro

32. Según la guía, ¿en qué unidades se necesita una especial actuación por la deshumanización que conlleva la pandemia?

A) Hospitalización y consultas externas.

B) UCI y Servicio de Urgencias.

C) Farmacia hospitalaria y rehabilitación.

D) Hospitalización a domicilio y atención primaria.

33. Conforme a la Guía de acompañamiento para pacientes ingresados por COVID-19 elaborada por el Comité de Ética del Área I del Servicio Murciano de Salud, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la justificación del acompañamiento se ajusta con mayor exactitud a lo dispuesto en la guía?

A) El acompañamiento está justificado en determinados pacientes, si bien debe atenderse al criterio clínico del paciente en ese momento.

B) El acompañamiento se justifica únicamente por la voluntad del familiar que lo solicita, sin valoración clínica alguna.

C) El acompañamiento se excluye de forma absoluta en todos los supuestos, dada la elevada contagiosidad del SARS-CoV-2.

D) El acompañamiento se autoriza de forma automática a todo paciente ingresado, sin necesidad de valorar su situación clínica.

34. ¿Cómo debe ser el sitio donde se cuida a los enfermos en el hospital?

A) Un sitio agradable y cómodo

B) Un sitio oscuro y con ruido

C) Un sitio frío y vacío

D) Un sitio sin ventanas

35. En la dimensión metodológica del 'CÓMO comunicar', ¿qué pauta debe observar rigurosamente el profesional sanitario?

A) Priorizar el rigor léxico clínico sobre la inteligibilidad del receptor.

B) Adaptar el registro lingüístico al nivel de competencia del usuario.

C) Delegar la transmisión técnica a medios escritos complementarios.

D) Condensar los contenidos omitiendo pautas relativas al estilo de vida.

36. En relación con los ingresos programados en UCI y la acogida de la familia, el protocolo contempla:

A) Prohibir cualquier visita previa al ingreso para evitar interferencias en la organización de la unidad.

B) Permitir visitas previas al ingreso con el fin de minimizar el estrés que genera el ingreso en la unidad.

C) Autorizar visitas previas únicamente cuando el paciente lo solicite por escrito.

D) Sustituir las visitas previas por material informativo entregado a la familia.

37. Respecto a las barreras percibidas por los profesionales para flexibilizar los horarios en UCI, ¿qué afirma el texto que demuestra la evidencia?

A) Que dichas barreras se confirman y justifican el mantenimiento de las restricciones de visita.

B) Que solo la limitada estructura del box constituye un obstáculo real e insalvable.

C) Que la evidencia demuestra todo lo contrario, ya que las acciones que disminuyen el estrés favorecen la seguridad del paciente y su familia.

D) Que la mayor ansiedad familiar ante procedimientos invasivos es el único efecto adverso documentado.

38. ¿Cuál de los siguientes NO se enumera en el texto como criterio de acompañamiento según la guía?

A) Menores de edad.

B) Embarazadas y parturientas.

C) Personas con deterioro cognitivo y/o demencia.

D) Personas con enfermedad crónica estabilizada sin dependencia.

39. Respecto a la formación continuada de los profesionales sanitarios según el texto, ¿cuál es su finalidad primordial?

A) Sustituir las competencias técnicas asistenciales por habilidades relacionales básicas.

B) Afrontar cualquier situación desde una perspectiva humanística ofreciendo calidad técnica y humana.

C) Delegar la toma de decisiones clínicas y éticas en los comités de participación ciudadana.

D) Restringir la comunicación de malas noticias a unidades de cuidados intensivos y urgencias.

40. ¿Cómo se llama la información que queremos contar o transmitir?

A) El canal

B) El receptor

C) El emisor

D) El mensaje

41. De acuerdo con la guía, ¿qué obligación se impone al acompañante del paciente COVID-19?

A) Someterse a una prueba diagnóstica antes de acceder a la unidad.

B) Realizar cuarentena posteriormente, además de ser informado de los riesgos de adquirir la enfermedad.

C) Permanecer en el hospital durante todo el ingreso sin posibilidad de ausentarse.

D) Firmar un documento que le exime al centro de toda responsabilidad sanitaria.

42. ¿Quién se siente mejor si la sala de espera es cómoda?

A) Las familias que esperan

B) Los coches del aparcamiento

C) Los jardines del hospital

D) Las máquinas de la cocina

43. ¿Para qué se pone una luz especial al lado de la cama de un enfermo?

A) Para que pueda leer si quiere

B) Para que no tenga miedo

C) Para calentar la comida

D) Para llamar a los bomberos

44. Según el texto, la ética en salud orienta y exige a dos colectivos principales. ¿Cuáles son?

A) Los investigadores y los comités de ética asistencial.

B) Los pacientes y sus familiares.

C) Los agentes de la salud y los directivos y ejecutivos que administran los centros sanitarios.

D) Los humanistas y los profesionales de la ciencia.

45. ¿Qué es una 'sala de estar' para las familias en el hospital?

A) Un sitio para que las familias descansen y pasen tiempo

B) Un cuarto lleno de camas de enfermos

C) Una tienda de juguetes

D) Un lugar donde se opera

46. ¿Cuál fue la evolución de los principios de la bioética según el material?

A) Inicialmente eran cuatro principios y posteriormente se suprimió el de justicia.

B) Inicialmente había tres principios (beneficencia, autonomía y justicia) y más tarde se añadió el de no maleficencia.

C) Inicialmente había tres principios (beneficencia, no maleficencia y justicia) y más tarde se añadió el de autonomía.

D) Inicialmente había dos principios (autonomía y justicia) y más tarde se añadieron beneficencia y no maleficencia.

47. ¿Quiénes formularon los cuatro principios de la bioética recogidos en el material (autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia)?

A) Beauchamp y Childress, en 1979.

B) Hipócrates y Galeno, en la tradición clásica.

C) Aristóteles y Platón, en la ética práctica.

D) Kant y Mill, en la ética teórica moderna.

48. Según la guía, ¿qué actuación del profesional contribuye directamente a disminuir la incertidumbre del paciente?

A) Escuchar y permitir que el paciente muestre sus emociones y miedos.

B) Proporcionar al paciente únicamente información escrita.

C) Limitar las visitas del acompañante para evitar contagios.

D) Realizar rondas médicas más frecuentes.

49. ¿A qué principio de la bioética corresponde el aforismo «primum non nocere» y el respeto a la integridad de la persona como ser humano?

A) Principio de beneficencia.

B) Principio de autonomía.

C) Principio de no maleficencia.

D) Principio de justicia.

50. De acuerdo con la guía, ¿cuál de los siguientes se considera criterio de acompañamiento justificado?

A) Personas con deterioro cognitivo y/o demencia

B) Personas con patología banal que acuden a consulta externa

C) Personas que rechazan expresamente el acompañamiento

D) Personas con alta hospitalaria programada

Hoja de Respuestas Correctas

1. C
2. B
3. C
4. C
5. B
6. C
7. A
8. A
9. A
10. B
11. A
12. B
13. A
14. A
15. A
16. B
17. D
18. B
19. A
20. A
21. B
22. A
23. C
24. B
25. A
26. B
27. A
28. A
29. C
30. B
31. A
32. B
33. A
34. A
35. B
36. B
37. C
38. D
39. B
40. D
41. B
42. A
43. A
44. C
45. A
46. B
47. A
48. A
49. C
50. A